

FRONT



care
GROUP



PATIENT INFORMATION LEAFLET

Device Type: Intraocular Lens (Phakic)

Introduction

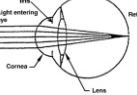
This patient information leaflet is designed to help you decide whether you want to have an Implantable Phakic Contact Lens (EYEPCL V2.0) placed in one or both eyes to correct your nearsightedness (myopia) or farsightedness (hyperopia). It is important to understand the benefits and possible risks before making your decision. Please read this leaflet carefully and discuss any questions with a doctor trained in EYEPCL V2.0 surgery.

What is Nearsightedness and Farsightedness?

NORMAL EYE

Light focuses on the retina.

Vision is clear.

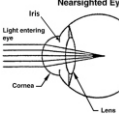


NORMAL EYE:

Your eye works like a camera. You see objects because your eye focuses light into images. Both the clear front layer of your eye, called the cornea, and your natural crystalline lens focuses rays of light onto the back surface of the eye, called the retina.

NEARSIGHTED EYE:

Nearsightedness is a focusing error that causes blurrer vision at distance than at near. Light from an object in the distance focuses in front of the back surface of your eye (retina) responsible for capturing images, rather than directly on the retina.

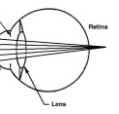


NEARSIGHTED EYE:

Light focuses in front of the retina. Vision is blurry.

FARSIGHTED EYE:

Light focuses behind the retina. Vision is blurry.



FARSIGHTED EYE:

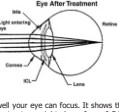
Farsightedness (hyperopia) is a common vision condition in which you can see distant objects clearly, but objects nearby may be blurry.

Glases and contact lenses can help your eye focus light properly on the retina. The EYEPCL V2.0 can also help your eye focus light properly on the retina.

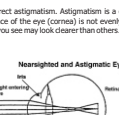
How Does EYEPCL V2.0 Correct Nearsightedness and Farsightedness?

CORRECTION OF VISION AFTER EYEPCL V2.0 SURGERY

NEARSIGHTED EYE



Eye After Treatment

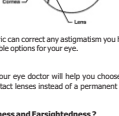


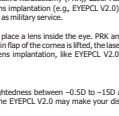
A diopter (D) is a unit to measure how well your eye can focus. It shows the level of nearsightedness, farsightedness, or astigmatism you have. EYEPCL V2.0 surgery can correct nearsightedness from -0.5 D to -15.0 D and farsightedness from +0.5 D to +15.0 D. If your vision falls within these ranges, the surgery may help you see clearly without glases or contact lenses.

The EYEPCL V2.0 monofocal lens does not correct astigmatism. Astigmatism is a common vision problem that causes blurred or uneven vision. It happens when the front surface of the eye (cornea) is not evenly shaped. Because of this, light does not focus properly inside the eye, and some parts of what you see may look clearer than others.

NEARSIGHTED AND ASTIGMATIC EYE

Nearsighted and Astigmatic Eye





EYEPCL V2.0 Toric / EYEPCL V2.0 Presbyopic Toric can correct any astigmatism you have up to +1.0 D to +10.0. You are requested to consult your doctor to choose the appropriate suitable options for your eye.

Choosing the best lens for your vision

There are different types of lenses available. Your eye doctor will help you choose the one that is best for you. Other treatment options include glases with thick lenses or contact lenses instead of a permanent lens implant. Talk to your eye doctor about the benefits and possible risks of each option.

Other Treatments to Correct Nearsightedness and Farsightedness?

Other treatments to correct nearsightedness and farsightedness include eyeglasses, contact lenses, and refractive surgical procedures. Surgical options include Photorefractive Keratectomy (PRK), Laser-Assisted In Situ Keratomileusis (LASIK), refractive lens exchange (RLE), and phakic intraocular lens implantation (e.g., EYEPCL V2.0). However, these procedures may not meet the visual requirements for certain professions, such as military service.

These procedures either reshape the cornea or place a lens inside the eye. PRK and LASIK use a laser to change the shape of the cornea so the eye can focus better. In LASIK, a thin flap of the cornea is lifted, the laser reshapes the tissue underneath, and the flap is replaced. If you choose to have phakic intraocular lens implantation, like EYEPCL V2.0, adds an artificial lens inside the eye to correct your vision.

Benefit And Risks of the EYEPCL V2.0

EYEPCL V2.0 surgery can safely correct nearsightedness between -0.50 to +15.0 and farsightedness between +0.50 to +15.0. If your eyeglass prescription is in these ranges, the EYEPCL V2.0 may allow you distance vision without eyeglasses or contact lens correction better.

Implanting EYEPCL V2.0 requires eye surgery, which carries potential risks. Please read this leaflet carefully and talk to your doctor about the possible risks.

Few of the risks are as below

- Additional surgery**
Sometimes, a second surgery may be needed to remove, replace, or adjust the EYEPCL V2.0. It may need to be removed during cataract surgery. Additional surgery might also be needed to reduce eye pressure.
- Cataract formation**
After Phakic IOL surgery, there is an increased risk that the natural lens of your eye may become cloudy, leading to cataracts that could require surgery. The longer the EYEPCL V2.0 stays in the eye, the higher this risk becomes. Regular eye exams are important to check for cataracts. The eyes and those with stronger nearsightedness or farsightedness may have a higher risk. The long-term risk beyond 7 years is not known. If cataract surgery is needed, the EYEPCL V2.0 and the cloudy lens are removed, and a new lens is implanted, until the next refraction surgery.
- Loss of Best Corrected Vision (BCVA)**
The most common reason was clouding of the natural (cataract) vision. You may get better in these eyes after cataract surgery.
- Raised pressure inside the eye and damage to the optical nerve caused by increased pressure in eye (Glaucoma)**
Normal eye pressure (intraocular pressure or IOP) can vary but is often considered to be from 10-21 millimeters of mercury (mmHg). An IOP higher than normal is called ocular hypertension or if left untreated, can cause damage to the optic nerve (glaucoma) and cause permanent vision loss.
- Endothelial Cell Loss**
The cornea (the clear front part of your eye) has a thin layer of special cells called endothelial cells. These cells keep the cornea clear by removing extra fluid. Normally, the number of these cells slowly decreases with age. Eye surgery, including EYEPCL V2.0, can cause additional loss of these cells. If too many cells are lost, the cornea can become cloudy and affect your vision. Before surgery, your doctor will examine your eyes to check if you are suitable for EYEPCL V2.0. After the surgery, some ongoing loss of these cells may occur over time. If too many cells are lost, fluid can build up in the cornea (called corneal edema), which may require a cornea transplant.
- Other Complications**
Other risks associated with EYEPCL V2.0 surgery may include:
 - movement of the colored portion of the eye (iris) through a surgical wound to a position outside the eye (iris prolapse),
 - check for extra fluid. Normally, the number of these cells slowly decreases with age. Eye surgery, including EYEPCL V2.0, can cause additional loss of these cells. If too many cells are lost, the cornea can become cloudy and affect your vision. Before surgery, your doctor will examine your eyes to check if you are suitable for EYEPCL V2.0. After the surgery, some ongoing loss of these cells may occur over time. If too many cells are lost, fluid can build up in the cornea (called corneal edema), which may require a cornea transplant.
 - bleeding under the retina (subretinal hemorrhage),
 - increase in focusing error (accommodation),
 - lifting or pulling of the retina from its natural position (retinal detachment),
 - unequal pupil size (anisocoria).

Adverse reactions and complications due to, or following surgery and implication of any implantable Phakic Contact Lens may include:

- Increased astigmatism
- Refractive error
- Intraocular infection
- Vitreous loss
- Waisting issue
- Anterior subcapsular cataract
- Severe intraocular inflammation
- Glaucoma
- Secondary glaucoma
- Uveitis
- Vitritis
- Hyphema
- Hyphema
- Hyphema
- Under/over correction
- Non-reactive pupil
- Endothelialitis
- TASS
- Retinal Detachment
- Iritis
- Ocular macular edema
- Macular edema
- Corneal decompensation
- Corneal edema
- Pupillary block
- Iris Capture
- IOP > 30mmHg over baseline and IOP > 25 mmHg
- Significant glares and/or halos after surgery
- Decentration/rotation of the EYEPCL V2.0
- Corneal endothelial cell loss
- Lens dislocation/rotation of the EYEPCL V2.0
- Loss of best spectacle corrected visual acuity



care

GROUP

LEO COMAROV



NOTICE D'INFORMATION DESTINÉE AU PATIENT

Type de dispositif : Lentille intraoculaire (phake)

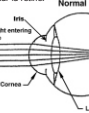
Introduction

Cette notice d'information destinée au patient a été conçue pour vous aider à décider si vous souhaitez qu'une lentille de contact phaque implantable (EVEPEX V2.0) soit implantée dans un ou dans deux yeux afin de corriger votre myopie ou votre hypermétropie. Il est important de comprendre les avantages et les risques potentiels avant de prendre votre décision. Veuillez lire attentivement cette notice et discuter de toute question avec un médecin formé à la chirurgie de l'EVEPEX V2.0.

Qu'est-ce que la myopie et l'hypermétropie ?

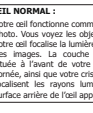
ŒIL NORMAL

La lumière se focalise sur la rétine. La vision est nette.



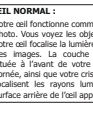
ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



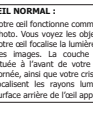
ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



Les lunettes et les lentilles de contact peuvent aider votre œil à focaliser correctement la lumière sur la rétine. L'EVEPEX V2.0 peut également aider votre œil à focaliser correctement la lumière sur la rétine.

Comment l'EVEPEX V2.0 corrige-t-elle la myopie et l'hypermétropie ?

CORRECTION DE LA VISION APRÈS UNE CHIRURGIE EVEPEX V2.0

ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



La dioptrie (D) est une unité utilisée pour mesurer la capacité de votre œil à effectuer correctement la mise au point. Elle indique le degré de myopie, d'hypermétropie ou d'astigmatisme dans votre œil atteint. La chirurgie EVEPEX V2.0 peut traiter la myopie de -0,5 à +15,0 D d'hypermétropie de +0,5 D à +10,0 D. Si votre degré visuel se situe dans ces plages, cette intervention peut vous aider à voir clairement sans lunettes ni lentilles de contact.

La lentille monofocale EVEPEX V2.0 ne corrige pas l'astigmatisme. L'astigmatisme est une trouble visuel fréquent qui provoque une vision floue ou irrégulière. Si avant l'opération la surface antérieure de l'œil (la cornée) n'a pas une forme parfaitement rigide. En conséquence, la lumière ne se focalise pas correctement à l'intérieur de l'œil et certaines parties de ce que vous voyez peuvent paraître plus nettes que d'autres.

ŒIL MYOPE ET ASTIGMATISME

ŒIL MYOPE ET ASTIGMATISME

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE ET ASTIGMATISME

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE ET ASTIGMATISME

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



ŒIL MYOPE ET ASTIGMATISME

La lumière se focalise devant la rétine. La vision est floue.



Le choix de la meilleure lentille pour vos yeux dépendra de votre vision et de vos besoins. Votre ophtalmologue vous aidera à choisir celle qui vous convient le mieux. Discutez avec votre médecin traitant comment les lunettes ou verres après les lentilles de contact au lieu d'un contact permanent. Discutez avec votre ophtalmologue des avantages et des risques potentiels de chaque option.

Autres traitements pour corriger la myopie et l'hypermétropie ?

Les autres traitements destinés à corriger la myopie et l'hypermétropie comprennent les lunettes, les lentilles de contact et les procédures chirurgicales réfractives. Les options chirurgicales comprennent la chirurgie extracapsulaire (LASIK), le laser in situ keratomileusé par laser (LASEK), l'échange de cristallin rétrofixé (RLI) et l'implantation de lentilles intraoculaires (phakes). Ces procédures peuvent vous aider à voir clairement sans lunettes ou verres après les lentilles de contact.

Ces procédures consistent soit à remodeler la cornée, soit à placer une lentille à l'intérieur de l'œil. La PRK et le LASEK utilisent un laser pour modifier la forme de la cornée (la surface antérieure de l'œil) afin de corriger la mise au point. Dans le LASEK, une fine voilette cornéenne est soulevée, le laser remodelle la tissu sous-jacent, puis la voilette est repositionnée afin de cicatriser. L'implantation d'une lentille intraoculaire phaque, telle que l'EVEPEX V2.0, ajoute une lentille artificielle à l'intérieur de l'œil sans retirer votre cristallin naturel.

Avantages et risques de l'EVEPEX V2.0

La chirurgie EVEPEX V2.0 peut corriger en toute sécurité la myopie comprise entre -0,5 D et +15,0 D ainsi que l'hypermétropie comprise entre +0,5 D et +10,0 D. Si votre correction optique se situe dans ces plages, l'EVEPEX V2.0 peut améliorer votre vision de bon sans lunettes ni lentilles de contact.

L'implantation de l'EVEPEX V2.0 nécessite une intervention chirurgicale complexe, qui comporte des risques potentiels. Veuillez lire attentivement cette notice et discuter avec votre médecin des risques éventuels.

Quelques-uns de ces risques sont décrits ci-dessous.

- Intervention chirurgicale supplémentaire
- Les autres risques associés à la chirurgie EVEPEX V2.0 peuvent nécessiter une intervention supplémentaire pour retirer, remplacer ou ajuster l'EVEPEX V2.0. Elle peut également devoir être retirée lors d'une chirurgie de la cataracte. Une intervention supplémentaire peut aussi être nécessaire afin de réduire la pression intraoculaire.
- Formation d'une cataracte
- Après une formation d'une lentille intraoculaire phaque, le risque que le cristallin naturel de votre œil devienne opaque est accru, ce qui peut entraîner une cataracte nécessitant une intervention chirurgicale. Plus l'EVEPEX V2.0 reste longtemps dans l'œil, plus le risque d'une cataracte est accru. Les patients plus âgés ainsi que ceux présentant une myopie ou une hypermétropie plus importante peuvent présenter un risque plus élevé. Le risque d'une long terme au-delà de 7 ans n'est pas connu. Si une chirurgie de la cataracte devient nécessaire, l'EVEPEX


care
GROUP
LEBENSVERSICHERUNG

PATIENTENINFORMATIONSBLATT

Produkttyp: Intraokularlinse (phak)

Einkleitung

Dieses Patienteninformatonssblatt soll Ihnen dabei helfen zu entscheiden, ob bei Ihnen eine implantierbare phake Kontaktlinse (EYECL V2.0) in einem oder beiden Augen eingesetzt werden soll, um Ihre Kurzsichtigkeit (Myopie) oder Weitsichtigkeit (Hyperopie) zu korrigieren. Es ist wichtig, die Vorteile und möglichen Risiken zu verstehen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt sorgfältig durch und besprechen Sie alle Fragen mit einem Arzt, der in der EYECL V2.0-Chirurgie erfahren ist.

Was sind Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit?

NORMALES AUGES:

Das Licht wird auf der Netzhaut fokussiert.
Das Sehvermögen ist klar.

KURZSICHTIGES AUGES:

Kurzsichtigkeit ist ein Brechungsfehler, der dazu führt, dass das Sehen in der Ferne unscharfer ist als das Sehen in der Nähe. Das Licht eines weit entfernten Objekts wird vor der Rückseite Ihres Auges (der Netzhaut), die für die Bildaufnahme verantwortlich ist, fokussiert, anstatt direkt auf der Netzhaut.

Weitsichtiges Auge

Kurzsichtigkeit ist ein Brechungsfehler, der dazu führt, dass das Sehen in der Ferne unscharfer ist als das Sehen in der Nähe. Das Licht eines weit entfernten Objekts wird vor der Rückseite Ihres Auges (der Netzhaut), die für die Bildaufnahme verantwortlich ist, fokussiert, anstatt direkt auf der Netzhaut.

WEITSICHTIGES AUGES:

Weitsichtigkeit (Hyperopie) ist eine häufige Sehstörung, bei der entfernte Objekte klar gesehen werden können, während nahe Objekte unscharf erscheinen können.

Brillen und Kontaktlinsen können Ihrem Auge helfen, das Licht korrekt auf die Netzhaut zu fokussieren. Auch die EYECL V2.0 kann Ihren Augen helfen, das Licht korrekt auf die Netzhaut zu fokussieren.

Wie korrigiert die EYECL V2.0 Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit?

SCHWERKURAT NACH EINER EYECL V2.0-OPERATION

Eine Dioptrie (D) ist eine Maßeinheit zur Bestimmung der Fokussierungsfähigkeit Ihres Auges. Sie zeigt den Grad Ihrer Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Ihres Astigmatismus an. Eine EYECL V2.0-Operation kann Kurzsichtigkeit von -0,5 D bis +15,0 D und Weitsichtigkeit von +0,5 D bis +15,0 D behandeln. Wenn Ihre Weitsichtigkeit innerhalb dieser Bereiche liegt, kann Ihnen diese Operation helfen, ohne Brille oder Kontaktlinsen auszukommen. Die EYECL V2.0 ist eine häufige Sehstörung, die verschwommenes oder ungleichmäßiges Sehen verursacht. Er entsteht, wenn die Vorderfläche des Auges (Hornhaut) nicht gleichmäßig geformt ist. Dadurch wird das Licht im Auge nicht korrekt fokussiert, und einige Bereiche des Schädels können schärfer erscheinen als andere.

KURZSICHTIGHEIT UND ASTIGMATISCHES AUGE

Nearighted and Astigmatic Eye

Eine Dioptrie (D) ist eine Maßeinheit zur Bestimmung der Fokussierungsfähigkeit Ihres Auges. Sie zeigt den Grad Ihrer Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Ihres Astigmatismus an. Eine EYECL V2.0-Operation kann Kurzsichtigkeit von -0,5 D bis +15,0 D und Weitsichtigkeit von +0,5 D bis +15,0 D behandeln. Wenn Ihre Weitsichtigkeit innerhalb dieser Bereiche liegt, kann Ihnen diese Operation helfen, ohne Brille oder Kontaktlinsen auszukommen. Die EYECL V2.0 ist eine häufige Sehstörung, die verschwommenes oder ungleichmäßiges Sehen verursacht. Er entsteht, wenn die Vorderfläche des Auges (Hornhaut) nicht gleichmäßig geformt ist. Dadurch wird das Licht im Auge nicht korrekt fokussiert, und einige Bereiche des Schädels können schärfer erscheinen als andere.

Vorteile und Risiken der EYECL V2.0

Die EYECL V2.0 ist eine Intraokularlinse (IOL), die zwischen der Hornhaut und der Netzhaut implantiert wird. Sie ersetzt die natürliche Linse des Auges. Die EYECL V2.0 ist eine Intraokularlinse (IOL), die zwischen der Hornhaut und der Netzhaut implantiert wird. Sie ersetzt die natürliche Linse des Auges.

Vorteile und Risiken der EYECL V2.0

Die EYECL V2.0 ist eine Intraokularlinse (IOL), die zwischen der Hornhaut und der Netzhaut implantiert wird. Sie ersetzt die natürliche Linse des Auges. Die EYECL V2.0 ist eine Intraokularlinse (IOL), die zwischen der Hornhaut und der Netzhaut implantiert wird. Sie ersetzt die natürliche Linse des Auges.

Einige dieser Risiken sind nachfolgend aufgeführt.

- Zusätzliche Operationen
- Mögliche Verletzung des farbigen Teils des Auges (Iris) durch eine Operationswunde in einer Position außerhalb des Auges
- Bildung im Bereich der Netzhaut, der für das Lesevermögen verantwortlich ist (Makulaablation).
- Blutung unter der Netzhaut (Subretinale Blutung). Wenn zu viele Zellen verloren gehen, kann die Hornhaut trüb werden und Ihr Sehvermögen beeinträchtigen.
- Abnahme oder Zug der Netzhaut aus ihrer natürlichen Position (Netzhautablösung).
- Entwicklung großer Pupillen (Anisokorie).

Nebenwirkungen und Komplikationen infolge einer nach einer Operation sowie der Implantation einer implantierbaren phaken Kontaktlinse können unter anderem folgendes umfassen:

- Zunahme des Astigmatismus
- Refraktionsfehler
- Intraokulares Trauma
- Verlust von Korneagewebe
- Nahtproblem
- Anteriore subkapsuläre Katarakt
- Schwere intraokulare Entzündung
- Glaukom
- Sekundäres Glaukom
- Uveitis
- Vitritis
- Hypothymia
- Hypopyon
- Kontaktkontakt/Überkontakt
- Nicht reagierende Pupille
- Endophthalmitis
- TACS (Toxic Anterior Segment Syndrome)
- Netzhautablösung
- Zyrtisches Makulödem
- Zyrtisches Glaukom
- Hornhautdegeneration
- Hornhautödem



care

GROUP

EUROPEAN

OPHTHALMOLOGICAL

INSTITUTE

FOGLIO INFORMATIVO PER IL PAZIENTE

Tipo di Dispositivo: Lente Intraoculare (Faccia)

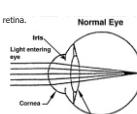
Introduzione

Questo foglio informativo per il paziente è stato progettato per aiutarla a decidere se desidera l'impianto di una Lente a Contatto Faccia Implantabile (EYECL V2.0) o uno o entrambi gli occhi per correggere la miopia o l'ipermetropia. È importante comprendere i benefici e i possibili rischi prima di prendere una decisione. La invitiamo a leggere attentamente questo foglio informativo e a discutere eventuali domande con un medico specializzato nella chirurgia EYECL V2.0.

Che cosa sono la miopia e l'ipermetropia?

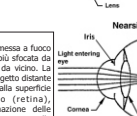
OCCHIO NORMALE

La luce si focalizza sulla retina. La visione è nitida.



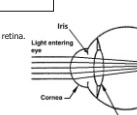
OCCHIO MIOPE

La miopia è un difetto di messa a fuoco che provoca una visione sfocata da lontano rispetto a quella da vicino. La luce proveniente da un oggetto distante viene focalizzata davanti alla superficie posteriore dell'occhio (retina), responsabile della formazione delle immagini, anziché direttamente sulla retina.



OCCHIO IPERMETROPE

L'ipermetropia è un difetto di messa a fuoco che provoca una visione sfocata da vicino. La luce proveniente da un oggetto distante viene focalizzata dietro la superficie posteriore dell'occhio (retina), responsabile della formazione delle immagini, anziché direttamente sulla retina.



OCCHIO NORMALE:

Il vostro occhio funziona come una macchina fotografica. Vedete gli oggetti perché l'occhio mette a fuoco la luce emanando immagini. Sia lo strato anteriore trasparente dell'occhio, chiamato cornea, sia il cristallino naturale focalizzano i raggi luminosi sulla superficie posteriore dell'occhio, chiamata retina.

OCCHIO MIOPE

La luce si focalizza davanti alla retina. La visione è sfocata.

OCCHIO IPERMETROPE:

L'ipermetropia è un comune difetto visivo in cui è possibile vedere chiaramente gli oggetti lontani, mentre quelli vicini possono apparire sfocati.

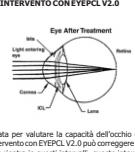
Gli occhi e le lenti a contatto possono aiutare l'occhio a focalizzare correttamente la luce sulla retina. Anche la EYECL V2.0 può aiutare l'occhio a focalizzare correttamente la luce sulla retina.

Come corregge la EYECL V2.0 la miopia e l'ipermetropia?

CORREZIONE DELLA VISIONE DOPO L'INTERVENTO CON EYECL V2.0

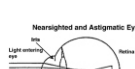
La diottria (D) è un'unità di misura utilizzata per valutare la capacità dell'occhio di mettere a fuoco. Indica il grado di miopia, ipermetropia e astigmatismo presente. L'intervento con EYECL V2.0 può correggere la miopia da -0.5 D a +15.0 D e l'ipermetropia da +0.5 D a +5.0 D. Se il vostro difetto visivo rientra in questi intervalli, questo intervento può aiutarvi a vedere chiaramente senza occhiali o lenti a contatto.

La correzione della visione dopo l'intervento con EYECL V2.0 non corregge l'astigmatismo. L'astigmatismo è un comune difetto visivo che provoca una visione sfocata o irregolare. Si verifica quando la superficie anteriore dell'occhio (cornea) non ha una forma uniforme. Per questo motivo, la luce non viene focalizzata correttamente al interno dell'occhio e alcune parti di ciò che vedete possono apparire più nitide di altre.



OCCHIO MIOPE E ASTIGMATICO

Nearsighted and Astigmatic Eye



La EYECL V2.0 Torica / EYECL V2.0 Presbiopia Torica può correggere l'astigmatismo da +1.0 D fino a +10.0 D. Vi invitiamo a consultarci il vostro medico per scegliere l'opzione più appropriata e adatta ai vostri occhi.

Scelta della lente migliore per la vostra vista

Sono disponibili diverse tipi di lenti. Il vostro medico vi aiuterà a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Altre opzioni di trattamento includono occhiali con lenti spesso o lenti a contatto in alternativa a un impianto permanente. Parlate con il vostro oculista dei benefici e dei possibili rischi di ciascuna opzione.

Altri trattamenti per correggere miopia e ipermetropia?

Altri trattamenti per correggere la miopia e l'ipermetropia includono occhiali, lenti a contatto e procedure chirurgiche refrattive. Le opzioni chirurgiche comprendono la Cheratomia Fotorefrattiva (PRK), la Cheratomia Laser Assista In Situ (LASIK), la Sostituzione Refrattiva del Cristallino (RLU) e l'impianto di una lente intraoculare facica (o esempio EYECL V2.0). Tuttavia, queste procedure potrebbero non soddisfare i requisiti visivi richiesti per alcune professioni, come il servizio militare.

Questo procedure modificano la forma degli occhi oppure prevedono l'inserimento di una lente all'interno dell'occhio. La PRK e la LASIK utilizzano un laser per modificare la forma della cornea in modo che l'occhio possa mettere a fuoco meglio. La LASIK, un trattamento comune, viene eseguito. Il laser modella il tessuto sottostante il lembo viene per riposizionare affinché possa guarire. L'impianto di una lente intraoculare facica, come la EYECL V2.0, aggiunge una lente artificiale all'interno dell'occhio senza rimuovere il cristallino naturale.

Benefici e rischi della EYECL V2.0

L'intervento con EYECL V2.0 può correggere in modo sicuro la miopia compresa tra -0.5 D e +15.0 D e l'ipermetropia compresa tra +0.5 D e +15.0 D. Se la vostra prescrizione per occhiali rientra in questi intervalli, la EYECL V2.0 può migliorare la vostra visione da lontano senza la necessità di occhiali o lenti a contatto. L'impianto della EYECL V2.0 richiede un intervento chirurgico oculare che comporta potenziali rischi. Vi invitiamo a leggere attentamente questo foglio informativo e a discutere con il vostro medico i possibili rischi.

Alcuni dei rischi sono riportati di seguito.

- Intervento chirurgico aggiuntivo
- In alcuni casi può essere necessario un secondo intervento per rimuovere, sostituire o regolare la EYECL V2.0. Potrebbe essere necessario rimuovere durante un intervento di cataratta. Un ulteriore intervento potrebbe anche essere richiesto per ridurre la pressione intraoculare.
- Formazione della cataratta
 - Dopo l'impianto di una IOL facica, esiste un rischio aumentato che il cristallino naturale dell'occhio diventi opaco, causando la cataratta. Questo rischio richiede un intervento chirurgico. Più a lungo la EYECL V2.0 rimane nell'occhio, maggiore diventa questo rischio. Sono importanti controlli oculistici regolari per monitorare l'eventuale comparsa della cataratta. I pazienti più anziani e quelli che hanno già la cataratta hanno un rischio maggiore di sviluppare la cataratta. Il rischio a lungo termine oltre i 7 anni non è noto. Se si rende necessario un intervento di cataratta, la EYECL V2.0 e il cristallino opacizzato vengono rimossi e viene impiantata una nuova lente, come avviene nella normale chirurgia della cataratta.
- Perdita della Migliore Acuità Visiva Correzionata (BCVA)
 - La causa più comune è l'opacizzazione del cristallino naturale (catartata). In questi occhi la vista può migliorare dopo l'intervento di cataratta.
 - Aumento della pressione intraoculare e danno al nervo ottico causato da una pressione elevata nell'occhio (Glaucoma)
 - Pressione normale dell'occhio (pressione intraoculare o IOP) può variare, ma è generalmente considerata compresa tra 10 e 21 millimetri di mercurio (mmHg). Una IOP superiore alla norma è definita ipertensione oculare e, se non trattata, può causare danni al nervo ottico (glaucoma) e portare a una perdita permanente della vista.
- Perdita delle cellule Endoteliali
 - Le cellule endoteliali che ricoprono l'endotelio (l'interno) possiedono un sottile strato di cellule specializzate chiamate cellule endoteliali. Queste cellule mantengono la cornea trasparente eliminando il liquido in eccesso. Normalmente, il numero di queste cellule diminuisce lentamente con l'età. La chirurgia oculare, compreso l'impianto della EYECL V2.0, può causare una perdita aggiuntiva di tali cellule. Se vengono perse troppe cellule, la cornea può diventare opaca e compromettere la vista.
 - Prima dell'intervento, il medico esaminerà i vostri occhi per verificare se siete idonei all'impianto della EYECL V2.0. Dopo l'intervento, il medico valuterà nel tempo una continua perdita di queste cellule. Se la perdita è eccessiva, può accumularsi liquido nella cornea (edema corneale), condizione che può richiedere un intervento di cataratta.
- Altre Complicanze
 - La chirurgia associata alla chirurgia con EYECL V2.0 possono includere:
 - spontaneo della parte cornea dell'occhio (idoneo) attraverso una ferita chirurgica verso una posizione esterna all'occhio (distacco dell'iride).
 - sanguinamento nell'area della retina responsabile della visione per la lenticola (emorraggia maculare),
 - sanguinamento sotto la retina (emorraggia sottoretinica),
 - aumento del difetto refrattivo (astigmatismo),
 - sollevamento o trazione della retina da una superficie naturale (distacco di retina),
 - diminuzione nei guai delle pupille (anisocoria).

Le lesioni vere e proprie e le complicanze dovute, a, a successo all'intervento chirurgico e all'impianto di qualsiasi Lente a Contatto Faccia Implantabile possono includere, ma non sono limitate a:

- Aumento dell'astigmatismo
- Esone refrattivo
- Infezione intraoculare
- Perdita di visione
- Problemi di walking
- Cataratta sottoretinica/epiretinica
- Grave infiammazione intraoculare
- Glaucoma
- Glaucoma secondario
- Infiammazione
- Irte
- Ispolonia
- Sottocorrezione/Sovracorrezione
- Pupilla non reattiva
- Endoftealmite
- TASS (Sindrome Torica del Segmento Anteriore)
- Distacco di retina
- Irte
- Edema maculare tossico
- Edema maculare
- Scoppio corneale
- Edema corneale
- Blecco pupillare
- Cultura dell'iride
- IOP > 5 mmHg rispetto al valore basale e IOP > 25 mmHg



CARE
GROUP
CARE GROUP

100%
SOLUÇÃO

FOLHETO INFORMATIVO PARA O DOENTE

Tipo de Dispositivo: Lente Intraocular (Fácula)

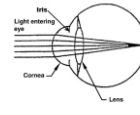
Introdução

Este folheto informativo para o doente foi concebido para o ajudar a decidir se pretende que seja implantada uma Lente de Contacto Fácula Implantável (EYEPL V2.0) num ou em ambos os olhos para corrigir a sua miopia (visão ao longe deficiente) ou hipermetropia (visão ao perto deficiente). É importante compreender os benefícios e os possíveis riscos antes de tomar a sua decisão. Leia atentamente este folheto e discuta quaisquer dúvidas com um médico treinado em cirurgia EYEPL V2.0.

O que é a miopia e a hipermetropia?

OLHO NORMAL

A luz é focada na retina.
A visão é nítida.



OLHO NORMAL:

O seu olho funciona como uma câmara fotográfica. Vê os objetos porque o seu olho foca a luz em imagens. Tanto a chamada frontal transparente do olho, denominada córnea, como o seu cristalino natural focam os raios de luz na superfície posterior do olho, denominada retina.

OLHO MÍOPE:

A miopia é um erro de focagem que provoca uma imagem mais desfocada ao longo do que ao perto. A luz proveniente de um objeto distante é focada à frente da superfície posterior do olho (retina), responsável pela captação das imagens, em vez de ser focada diretamente sobre a retina.

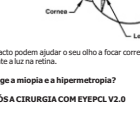


OLHO HÍPOPE

A luz é focada à frente da retina.
A visão é desfocada.

OLHO HIPERMÉTROPE:

A luz é focada atrás da retina.
A visão é desfocada.



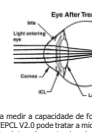
OLHO HIPERMÉTROPE:

A hipermetropia é uma condição visual comum em que consegue ver claramente os objetos distantes, mas os objetos próximos podem parecer desfocados.

Os olhos e as lentes de contacto podem ajudar o seu olho a focar corretamente a luz na retina. A EYEPL V2.0 também pode ajudar o seu olho a focar corretamente a luz na retina.

Como a EYEPL V2.0 corrige a miopia e a hipermetropia?

CORREÇÃO DA VISÃO APÓS A CIRURGIA COM EYEPL V2.0

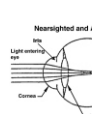


Eye After Treatment

A dioptria (D) é uma unidade utilizada para medir a capacidade de focagem do olho. Indica o grau de miopia, hipermetropia ou astigmatismo que possui. A cirurgia com EYEPL V2.0 pode tratar a miopia de -0.5 D a -15.0 D e a hipermetropia de +0.5 D a +15.0 D. Se a sua visão se encontrar dentro destes intervalos, esta cirurgia poderá ajudá-lo a ver claramente sem óculos ou lentes de contato.

A lente monofocal EYEPL V2.0 não corrige o astigmatismo. O astigmatismo é um problema visual comum que provoca visões desfocadas tanto no interior do olho quanto no exterior do olho (córneas) não tem uma forma uniforme. Como resultado, a luz não é focada corretamente no interior do olho e algumas partes do que vê podem parecer mais nítidas do que outras.

OLHO MÍOPE E ASTIGMATISMO



Nearighted and Astigmatic Eye

A EYEPL V2.0 Tórica / EYEPL V2.0 Tórica para Presbiopia pode corrigir qualquer astigmatismo entre +1.0 D e +1.0 D. Recomendamos que consulte os seus médicos para garantir que as opções são adequadas para o seu olho.

Escolher o melhor lenço para a sua visão

Existem diferentes tipos de lentes disponíveis. Um oftalmologista qualificado irá escolher a que melhor se adequa a si. Outras opções de tratamento incluem óculos com lentes espessas ou lentes de contacto em vez de um implante permanente. Fale com o seu oftalmologista sobre os benefícios e os possíveis riscos de cada opção.

Outros tratamentos para corrigir a miopia e a hipermetropia?

Outros tratamentos para corrigir a miopia e a hipermetropia incluem óculos, lentes de contacto e procedimentos cirúrgicos refrativos. As opções cirúrgicas incluem a Correção Refrativa Femtosecundária (PRK), a Correção Refrativa Assistida por Laser In Situ (LASIK), a troca refrativa do cristalino (RLR) e a implantação de lentes intraoculares (como, por exemplo, EYEPL V2.0). No entanto, estes procedimentos podem não satisfazer os requisitos visuais de determinadas profissões, como o serviço militar.

Estes procedimentos remodelam a córnea ou colocam uma lente no interior do olho. A PRK e o LASIK utilizam um laser para alterar a forma da córnea, permitindo que o olho enfoque melhor. No LASIK, é levantado um fino retalho da córnea, o laser remodela o tecido subjacente e o retalho é recolocado para cicatrizar. A implantação de uma lente intraocular fácula, como a EYEPL V2.0, adiciona uma lente artificial no interior do olho sem remover o cristalino natural.

Benefícios e riscos da EYEPL V2.0

A cirurgia com EYEPL V2.0 pode corrigir de forma segura a miopia entre -0.5 D e -15 D e a hipermetropia entre +0.5 D e +15 D. Se a sua graduação ocular se enquadrar nestes intervalos, a EYEPL V2.0 poderá melhorar a sua visão ao longo se sempre necessitar de correção com óculos ou lentes de contacto.

A implantação da EYEPL V2.0 requer numeração ocular, a qual envolve riscos potenciais. Leia atentamente este folheto e converse com o seu médico sobre os possíveis riscos.

- Alguns dos riscos incluem:
 - Cirurgia adicional

Por vezes, pode ser necessária uma segunda cirurgia para remover, substituir ou ajustar a EYEPL V2.0. A lente pode necessitar de ser removida durante uma cirurgia láz catalana. Também poderá ser necessária uma cirurgia adicional para induzir a pressão ocular.

- Formação de catarata

Após a cirurgia com LIO fácula, existe um risco aumentado de o cristalino do olho se tornar opaco, levando ao desenvolvimento de cataratas que poderão necessitar de cirurgia. Quanto mais tempo a EYEPL V2.0 permanecer no olho, maior será este risco. Os exames oftalmológicos regulares são importantes para monitorizar o aparecimento de cataratas. Os doentes mais suscetíveis a cataratas com miopia ou hipermetropia mais acentuadas podem apresentar um risco mais elevado. O risco a longo prazo para desenvolver cataratas após a cirurgia com EYEPL V2.0 pode variar, mas é geralmente considerado entre 10 e 21 milímetros de mercúrio (mmHg). Uma pupila superior ao normal é denominada hipertensão ocular, e se não for tratada, pode causar danos no nervo ótico (glaucoma) e provocar perda permanente da visão.

- Perda da Memória Visual Única Corrigida (BVCA)

A causa mais comum para a especificação do cristalino natural (catarata) é a perda da memória visual única corrigida (BVCA).

- Aumento da pressão intraocular e lesão do nervo ótico causada pelo aumento da pressão no olho (Glaucoma)

Se a grande pupila (miopia) ou pequena pupila (hipermetropia) ou PUD) pode variar, mas é geralmente considerada entre 10 e 21 milímetros de mercúrio (mmHg). Uma pupila superior ao normal é denominada hipertensão ocular, e se não for tratada, pode causar danos no nervo ótico (glaucoma) e provocar perda permanente da visão.

- Perda de células endoteliais

Quando a parte frontal transparente do olho possui uma fina camada de células especiais denominadas células endoteliais. Estas células mantêm a córnea transparente removendo o excesso de fluido. Normalmente, o número destas células diminui lentamente com a idade. A cirurgia ocular (hipermétrope ou miopia) pode causar uma perda adicional destas células. Se forem perdidas demasiadas células, a córnea pode tornar-se opaca e afetar a visão. Após a cirurgia, o seu médico examinou os seus olhos para verificar se é um candidato adequado para a EYEPL V2.0. Antes da cirurgia, pode ocorrer alguma perda contínua destas células devido ao uso de medicamentos para dilatar a pupila. A cirurgia ocular pode acumular-se líquido na córnea (denovada retina corneal), o que poderá exigir um transplante de córnea.

Outras complicações

- Riscos associados à cirurgia com EYEPL V2.0 podem incluir:
 - deslocamento da parte colorida do olho (íris) através de uma ferida cirúrgica para uma posição fora do olho (prolapso da íris),
 - hemorragia na área da retina responsável pela visão de longe (hemorragia macular),
 - hemorragia na retina (hemorragia sub-retiniana),
 - aumento do erro refrativo (astigmatismo),
 - elevação ou tração retinal da sua pupila natural (descolamento da retina),
 - tamanho desigual das pupilas (anisocoria).

As reações adversas e complicações decorrentes da cirurgia e da implantação de qualquer Lente de Contacto Fácula Implantável podem incluir, mas não se limitam a:

- Aumento do astigmatismo
- Alteração refrativa
- Infecção intraocular
- Perda de visão
- Problema de vaulting
- Catarata subsupilar anterior
- Inflamação intraocular grave
- Glaucoma secundário
- Uveíte
- Vitrite
- Hifema
- Hipópio
- Subconjuntivite/conjunctivite
- Pupila não reativa
- Endoftalmite
- TASS
- Descolamento da retina
- Íris
- Edema macular cistide
- Edema macular
- Descompensação comansia
- Externa comansia
- Bloqueio pupilar
- Captura de íris
- PIO > 5 mmHg acima do valor basal de PIO > 25 mmHg

Encadernamento significativo e/ou halos em redor das luzes





FOLLETO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Tipo de dispositivo: Lente Intraocular (Fáquica)

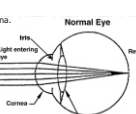
Introducción

Este folleto de información para el paciente está diseñado para ayudarte a decidir si deseas que se te implante una Lente de Contacto Fáquica Implantable (EYECL V2.0) en uno o ambos ojos para corregir su miopía e hipermetropía. Es importante comprender los beneficios y los posibles riesgos antes de tomar su decisión. Les adelantamos este folleto y consulte cualquier duda con un médico especialista en cirugía EYECL V2.0.

¿Qué son la miopía y la hipermetropía?

OJO NORMAL

La luz se enfoca en la retina.
La visión es nítida.

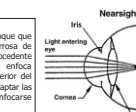


OJO NORMAL:

Su ojo funciona como una cámara. Usted ve los objetos porque su ojo enfoca la luz para formar imágenes. Tanto la cara frontal transparente del ojo, llamada córnea, como el cristalino nativo enfocan los rayos de luz sobre la superficie posterior del ojo, llamada retina.

OJO MIOPE:

La miopía es un error de enfoque que provoca una visión más borrosa de lejos que de cerca. La luz procedente de un objeto distante se enfoca delante de la superficie posterior del ojo (retina), responsable de captar las imágenes, en lugar de enfocarse directamente sobre la retina.

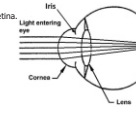


OJO MIOPE

La luz se enfoca delante de la retina.
La visión es borrosa.

OJO HIPERMÉTROPE

La luz se enfoca detrás de la retina.
La visión es borrosa.



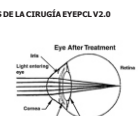
OJO HIPERMÉTROPE:

La hipermetropía es una afecación visual común en la que puede ver claramente los objetos lejanos, pero los objetos cercanos pueden verse borrosos.

Las gafas y las lentes de contacto pueden ayudar a que el ojo enfoque correctamente la luz sobre la retina. La EYECL V2.0 también puede ayudar a que el ojo enfoque correctamente la luz sobre la retina.

¿Cómo corrige la EYECL V2.0 la miopía y la hipermetropía?

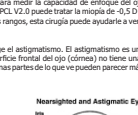
CORRECCIÓN DE LA VISIÓN DESPUÉS DE LA CIRUGÍA EYECL V2.0



Una dioptría (D) es una unidad utilizada para medir la capacidad de enfoque del ojo. Indica el grado de miopía, hipermetropía o astigmatismo que presenta. La cirugía EYECL V2.0 puede tratar la miopía de -0.5 D a -15.0 D y la hipermetropía de +0.5 D a +15.0 D. El tratamiento se realiza durante dos etapas riêngas, esta cirugía puede ayudarle a ver con claridad sin necesidad de gafas o lentes de contacto.

La lente monofocal EYECL V2.0 no corrige el astigmatismo. El astigmatismo es un problema visual frecuente que provoca una visión borrosa o irregular. Aunque tenga la superficie frontal del ojo (córnea) no tiene una forma uniforme. Como resultado, la luz no va exactamente al centro derecho del ojo o algunas partes de lo que ve pueden parecer más claras que otras.

OJO MIOPE Y ASTIGMATICO



EYECL V2.0 Trátala / EYECL V2.0 Trátala para Presbicia puede corregir el astigmatismo que presente desde +1,0 D hasta +10 D. Se recomienda consultar con un médico para elegir el grado más adecuado para su ojo.

Cómo elegir la mejor lente para su visión

Existen diferentes tipos de lentes disponibles. Su oftalmólogo le ayudará a elegir la que mejor se adapte a usted. Otras opciones de tratamiento incluyen gafas con lentes gruesas o lentes de contacto en lugar de un implante permanente. Hable con su oftalmólogo sobre los beneficios y los posibles riesgos de cada opción.

¿Quié otros tratamientos existen para corregir la miopía y la hipermetropía?

Otros tratamientos para corregir la miopía y la hipermetropía incluyen gafas, lentes de contacto y procedimientos quirúrgicos refractivos. Los options quirúrgicos incluyen la queratomilesia fotorefractiva (PRK), la queratomilesia in situ asistida por láser (LASIK), el intercambio de cristalino refractivo (RLE) y la implantación de lentes intraoculares fáquicas (por ejemplo, EYECL V2.0). Sin embargo, estos procedimientos pueden no cumplir con los requisitos visuales de determinadas profesiones (como el servicio militar).

Otros procedimientos remodelan la córnea o colocan una lente dentro del ojo. La PRK y el LASIK utilizan un láser para modificar la forma de la córnea y mejorar el enfoque del ojo. En el EYCL V2.0, se levanta una fina lámina de la córnea, él lente remodela el tejido subyacente y posteriormente la lámina se recoloca para que cicatrice. La implantación de una lente intraocular fáquica, como la EYECL V2.0, añade una lente artificial dentro del ojo sin retirar el cristalino nativo.

Beneficios y riesgos de la EYECL V2.0

La cirugía EYECL V2.0 puede proporcionar una buena mejora a miopía entre -0,5 D – -15 D, y la hipermetropía entre +0,5 D + +15 D. Si su graduación se encuentra dentro de estas rangos, la EYECL V2.0 puede mejorar su visión lejana sin necesidad de gafas o lentes de contacto.

La implantación de la EYECL V2.0 requiere cirugía ocular, la cual conlleva riesgos potenciales. Les adelantamos este folleto y consulte con su médico sobre los posibles riesgos:

- Algunos de los riesgos son los siguientes:
 - Cirugía accidentada
 - En ocasiones puede ser necesaria una segunda intervención quirúrgica para retirar, reemplazar o ajustar la EYECL V2.0. Puede ser necesario retirarla durante la cirugía de cataratas. También puede requerirse una operación adicional para reducir la presión ocular.
 - Formación de cataratas

Después de la cirugía con una lente intraocular fáquica, existe un mayor riesgo de que el cristalino nativo del ojo se vuelva opaco (opacidades traslúcidas) debido a la posible requirir cirugía. Cuanto más tiempo permanezca la EYECL V2.0 dentro del ojo, mayor será el riesgo. Los exámenes oculares periódicos son importantes para detectar la aparición de cataratas. Los pacientes de mayor edad y aquellos cuyos ojos más elevados de miopía o hipermetropía puedan presentar un riesgo superior. Se desconoce el riesgo a largo plazo más allá de los 10 años.

Si se producen cambios de cataratas, se retirará tanto la EYECL V2.0 como el cristalino opaco, y se implantará una nueva lente, de forma similar a una cirugía de cataratas convencional.

- Pérdida de la Mejor Agudeza Visual Corregida (BCVA)

La causa más frecuente fue la opacificación del cristalino (catata). La visión puede mejorar en los primeros años después de la cirugía de cataratas.

- Aumento de la presión dentro del ojo y daño al nervio óptico causado por el incremento de la presión ocular (Glaucoma)

La presión ocular normal (presión intraocular o PIO) puede variar, pero generalmente se considera que se encuentra entre 10 y 21 milímetros de mercurio (mmHg). Una PIO superior a lo normal se denomina hipertensión ocular, y si no se trata, puede causar daños al nervio óptico (glaucoma) y provocar una pérdida permanente de la visión.

- Pérdida de células endoteliales

La célula (la parte frontal transparente del ojo) posee una fina capa de células especiales llamadas células endoteliales. Estas células mantienen el líquido dentro del ojo eliminando el exceso de líquido. Normalmente, el número de estas células disminuye lentamente con la edad. La cirugía ocular, incluida la EYECL V2.0, puede causar una pérdida adicional de estas células. Si se pierden demasiadas células, la cirugía puede volverse opaca y afectar su visión.

Antes de la cirugía, su médico examinará su ojo para comprobar si es un candidato adecuado para la EYECL V2.0. Después de la cirugía, produce una pérdida continua de estas células con el paso del tiempo. Si se pierden demasiadas células, puede ocasionarse glaucoma en la córnea (deformación de esta célula), lo que podría requerir un trasplante de córnea.

- Otras complicaciones

Otros riesgos asociados con la cirugía EYECL V2.0 pueden incluir:

- desplazamiento de la parte coloreada del ojo (iris) a través de una herida quirúrgica hacia una posición fuera del ojo
- hemorragia en el área de la retina responsable de la visión de lectura (hemorragia macular),
- desplazamiento de la retina (hemorragia subretiniana),
- aumento del error de enfoque (astigmatismo),
- desprendimiento o tracción de la membrana vitrea (su posición natural (desprendimiento de retina),
- tamaño desigual de las pupilas (anisocoria).

Las reacciones adversas y complicaciones debidas a la cirugía o posteriores a ella, así como a la implantación de cualquier Lente de Contacto Fáquica Implantable, pueden incluir, entre otras:

- Aumento del astigmatismo
- Error refractivo
- Infección intraocular
- Pérdida de vítreo
- Problemas de vaulting
- Catara subcapsular anterior
- Inflamación intraocular grave
- Glaucoma secundario
- Uveitis
- Vitritis
- Hifema
- Hipoxión
- Corrección insuficiente/excesiva
- Pupila no reactiva
- Endoftalmitis
- TASS (Síndrome tóxico del segmento anterior)
- Deshidratación de retina
- Iritis
- Edema macular quístico
- Edema macular
- Descompensación ocular
- Edema corneal
- Bloqueo pupilar
- Captura del iris

375 x 250 mm

- Secondary surgical intervention to remove/replace the EYEPCL V2.0
- Implantation of an EYEPCL V2.0 may result in a decrease in central endothelial cell density

Contraindications and Warnings

- Implantable Phakic Contact Lens (EYEPCL V2.0) is contraindicated in the presence of any of the following circumstances and/or conditions but not limited to the following: Patients with a history of/for clinical signs of iris, uveitis, synchysis, pigment dispersion syndrome, retinal disease (other than manifestation of myopia degeneration), chronic intraocular inflammation, macular degeneration, irregular astigmatism, keratoconus or ectatic macular edema in either eye
- Patients with diabetic retinopathy in either eye
- Patients with contact glaucoma in either eye
- Patients with history of previous intraocular surgery (including refractive surgery) in the eye to be treated
- Patients with a history of uveitis in either eye
- Patients who are amblyopic or blind in the fellow eye
- Patients who do not fall in the range of pre-treatment myopia and/or astigmatism as outlined in this
- clinical prescreen inclusion criteria
- Patients with a progressive sight-threatening disease. Patients with retinal findings associated with pathological myopia are allowed.
- Patients with a diagnosis of ocular hypertension
- Patients with contact glaucoma in either eye
- Patients with Fuchs's dystrophy or other central pathology
- Patients with cataract in either eye
- Patients with an unstable refractive error in the past 12 months (myopia and/or astigmatism)
- Patients who are pregnant or nursing
- Patients with low/normal central endothelial cell density
- Patients with Anterior chamber depth <2.8mm

Are You A Good Candidate For EYEPCL V2.0 Surgery?

Your corneal topograpy a detailed eye check-up to see if EYEPCL V2.0 surgery is suitable for you. You may be considered for this surgery if you:

- are 20 to 45 years old (for Monofocal and Toric lenses) or 40 to 60 years old (for presbyopic lenses)
- have nearsightedness between -0.5 D to -15.0 D or farsightedness between +0.5 D to +1.0 D (for EYEPCL V2.0 Monofocal and EYEPCL V2.0 Toric) and astigmatism between +1.0 D and +10.0 D (for EYEPCL V2.0 Presbyopic and EYEPCL V2.0 Presbyopic Toric)
- have a regular astigmatism (for toric lenses), if applicable
- have enough space inside your eye to safely place the lens
- have a healthy endothelium (the inner layer of your eye) with enough cells (endothelial cells) on the innermost surface of the cornea, responsible for keeping the cornea clear. If your doctor determines that your endothelial cell density is below the minimum level, you will be greater risk of swelling of your cornea (corneal edema), possibly requiring removal and replacement of your corneal transplant
- have written evidence that your nearsightedness or farsightedness has been stable for at least 1 year;
- have no corneal irregularities or scars that may affect your ability to drive after the procedure, also you must
- have no known allergies to any of the medications that your doctor may discuss will be used before, during and after the procedure
- are not pregnant or breastfeeding
- understand that at between 2 to 3 weeks before EYEPCL V2.0 surgery you will need to have holes made in the extreme outer edge of the colored portion of the eye (peripheral iridectomy) using a laser
- are willing to sign a consent form before the procedure

You and your doctor will determine if you are a suitable candidate for the EYEPCL V2.0 (monofocal, toric, presbyopic and presbyopic toric) and the frequency of follow-up visits to monitor and adjust the health of your eye.

What Should You Expect During EYEPCL V2.0 Surgery?

Before the Surgery

Before surgery, your doctor will review the medical and eye history and examine both eyes to make sure you are healthy and suitable for EYEPCL V2.0. This includes the frequency of the inner layer of your cornea (endothelium). If you wear contact with low/normal central endothelial cell density, you should not wear them for at least 2 to 4 weeks before your eye check-up and surgery. This helps your doctor get accurate measurements. Not doing this may affect your results.

After your doctor has given you any medicines you may need, eye problems, past eye surgeries, medical conditions, or allergies. Ask if you should not eat, drink, before surgery. Arrange for someone to take you home, so you should not drive right after the procedure. Your doctor will tell you when it is safe to drive again.

Two to Three Weeks before Surgery

Two to three weeks before your EYEPCL V2.0 surgery, your doctor will make two holes in the extreme outer edge of the colored portion of the eye (peripheral iridectomy) using a laser. This procedure is done to prevent the possibility of angle closure glaucoma. If the fluid flows properly from the back chamber to the front chamber of the eye to prevent a buildup of pressure within the eye after the lens is placed. Your doctor will usually apply numbing drops to the eye and make tiny incisions in the colored portion of the eye (iris) with a laser beam. Usually, this procedure does not affect your ability to drive after the procedure but check with your doctor. After the peripheral iridectomy procedure, you will be prescribed eye drops for you to use. It is important that you follow all medication instructions. Your doctor will instruct you to discontinue the use of these medications before the day of surgery.

On the Day of Surgery

On the day of surgery, eye drops will be placed in your eye to enlarge (dilate) the black part of your eye (pupil). Once your pupil is fully dilated, your doctor will put numbing drops in your eye and/or inject with numbing medication into your eye and ask you to lie on your back on the treatment table in the treatment room. Your doctor may discuss different options for numbing or relaxing you before the surgery. A small cut is made in the cornea (the clear front part of the eye), and the EYEPCL V2.0 lens is placed in the eye and centered inside your eye. The procedure usually takes about 20 to 30 minutes.

After the surgery, your doctor will apply eye drops or ointment and may cover your eye with a patch or shield for protection. The procedure is painless due to the numbing medicines. Do not drive yourself home after surgery. Arrange someone for someone to take you home in advance.

The First Day after Surgery

Your doctor will check your vision the day after surgery, including measuring the pressure in your eye. You may feel sensitive to light or feel like something is in your eye. Wearing sunglasses can help. Some discomfort or mild pain is normal, and your vision may give you difficulty to see clearly. If you have any of these symptoms, you should not use eye drops or ointment for about a week to prevent infection and reduce inflammation.

IMPORTANT: Use the eye medications as directed by your eye doctor. (Your results may depend upon you following your doctor's instructions).

DO NOT touch your eyes, especially for the first 3 to 5 days after surgery. If you notice any sudden decrease in vision, you should contact your doctor immediately. Wear sunglasses if you experience any of the following symptoms:

Long Term Care: In some cases, the EYEPCL V2.0 may need to be replaced or revised. It may be replaced if another lens is better suited for your eye or you can give you better vision. It may be revised if you develop a cataract and need cataract surgery in such cases, a new lens can be implanted to help correct your vision.

EYEPCL V2.0 is removed, you will lose your vision completely if removed. Your vision may not be the same as before surgery. It is important to follow your doctor's advice and attend all follow-up visits after surgery.

Questions To Ask Your Doctor

You may want to ask the following questions to help decide if EYEPCL V2.0 surgery for nearsightedness or farsightedness is right for you:

- What other options do I have to correct my nearsightedness or farsightedness?
- Will I have to limit my activities after surgery and for how long?
- How will be the benefits of EYEPCL V2.0 surgery and for what amount of nearsightedness and farsightedness?
- How long will I have to wait before I can have surgery in my other eye?
- How long will I have to wait before I can have surgery in my other eye?
- What vision problems might I experience if I have EYEPCL V2.0 even in 1 eye?
- How often? Could my need for eyeglasses increase over time? Could I undergo a different type of eye surgery for the correction of my vision?
- How long? EYEPCL V2.0 surgery likely to affect my need to wear eyeglasses or contacts less as 1 year after?
- Will my eyes heal differently, if injured after implantation of the EYEPCL V2.0?
- Should I have EYEPCL V2.0 surgery in my other eye?
- How long will I have to wait before I can have surgery in my other eye?
- What vision problems might I experience if I have EYEPCL V2.0 even in 1 eye?

Summary of Important Information

- EYEPCL V2.0 surgery provides a permanent correction of your nearsightedness or farsightedness as long as the EYEPCL V2.0 remains in the eye. The EYEPCL V2.0 may need to be replaced, if it is removed, you will lose this benefit, and your vision may not be the same as before surgery.
- EYEPCL V2.0 surgery does not eliminate the need for reading glasses, even if you have never worn them before.
- Quantities to follow your doctor's advice and attend all follow-up visits after surgery.
- Your vision may be stable before EYEPCL V2.0 surgery. You must provide written evidence that your nearsightedness or farsightedness has changed by no more than 0.50 D each year for at least 1 year.
- If you are pregnant or breastfeeding, you should wait before having the surgery.
- Like all surgeries, EYEPCL V2.0 has risks. It is important to read and understand all the information before deciding.
- Other options to correct your vision include glasses, contact lenses, and surgeries like RK, PRK, and LASIK.
- Before considering EYEPCL V2.0 surgery you should:
- have a complete eye examination.
- talk with at least one eye care professional about EYEPCL V2.0 surgery, especially the potential benefits, risks, and complications. You should discuss the time needed for healing after surgery.

Magnetic Resonance Compatibility: The implanted IOL does not contain any metallic components and is safe with no potential for interaction with the Magnetic Resonance (MR) field. IOL is safe for Magnet Resonance Imaging (MRI) at a magnetic field strength of 1.5 and 3.0 Tesla.

Expected benefits and necessary follow-up
The IOL will usually last for your lifetime. Should you however encounter any deterioration in your vision quality, please consult your eye doctor for further investigation and treatment. Your eye doctor will discuss with you the necessary follow-up intervals based on your medical condition.

Reporting of serious incidents

Any incident related that occurs in connection to the intraocular lens should be reported to your doctor (in the first instance), to the local representative or to the CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED.

About this document

Your eye doctor has performed the refractive surgery and implanted the intraocular lens (IOL) in your eye. The patient implant card and leaflet have been given to you after the surgery. Please always carry the patient implant card with you to facilitate medical care.

This document is provided to the implant card and provide you latest updates about the IOL.

Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2020/00163
Manufactured by:
CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED
Block No.: 31/0/CE, Village Dabhata, Taluka - Padra,
Distt. Vadodra - 391 440, Gujarat, India
Tel No.: 1800 120 3688
customercare@cargroupindia.com
www.caregroupindia.com

- Décompensation cornéenne
- Edème cornéen
- Bloc pupillaire
- Capture de l'iris
- Perte de cellules endothéliales
- Perte de cellules endothéliales cornéennes
- Éblouissements importants dûs aux halos autour des lumières
- Décentrement/rotation de l'EYEPCL V2.0
- Perte de cellules endothéliales cornéennes
- Lésion/rotation de l'EYEPCL V2.0
- Localisation/rotation de l'EYEPCL V2.0
- Intervention chirurgicale secondaire pour retirer/remplacer l'EYEPCL V2.0
- Implantation d'un EYEPCL V2.0 peut entraîner une diminution de la densité des cellules endothéliales cornéennes.

Contre-indications et avertissements

- La lentille de contact phakique implantable (EYEPCL V2.0) est contre-indiquée en présence de l'une des circonstances et/ou affections suivantes, sans s'y limiter : patients ayant des antécédents ou des signes cliniques d'iris, d'uvéïte, de synchysis, de syndrome de dispersion pigmentaire, de maladie rétinienne (autres que les manifestations de dégénérescence myopique), d'inflammation intraoculaire chronique, de dégénérescence maculaire, d'astigmatisme irrégulier, de kératocône, de dystrophie maculaire cystoïde dans l'un ou l'autre œil.
- Patients atteints de glaucome dans l'un ou l'autre œil.
- Patients atteints de rétinopathie diabétique dans l'un ou l'autre œil.
- Patients ayant une maladie oculaire chronique ou autre pathologie
- Patients avec une instabilité réfractive dans les 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme)
- Patients qui sont enceintes ou allaitent
- Patients avec une grossesse ou allaitement
- Patients atteints de diabète sucré non contrôlé
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patients atteints ou susceptibles d'être atteints de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définitif dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie oculaire menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétinienne associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hyperplasie oculaire.
- Patients atteints de diabète insulino-dépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable à l'occasion des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
-